

Concours 05 10 2023

1) L'examen radiographique du rachis :

- a) remplace l'examen clinique
- b) complète l'examen clinique
- c) ne remplace pas l'examen clinique
- d) ne complète pas l'examen clinique.

2) L'examen radiologique du rachis s'exécute en principe en :

- a) décubitus dorsal chez les traumatisés
- b) en station verticale chez les traumatisés
- c) décubitus dorsal chez les rhumatoïdes
- d) en station verticale chez les rhumatoïdes.

3) Un examen normal du rachis cervical comporte :

- a) 2 clichés
- b) 3 clichés
- c) 4 clichés
- d) 5 clichés.

4) En urgence, la radiographie du rachis cervical la plus importante est :

- A) Face
- b) Profil
- c) OPG et OPD
- d) OAG et OPG.

5) L'incidence de profil du rachis cervical est indiquée pour :

- a) étudier les éléments squelettiques du rachis cervical
- b) étudier la courbure rachidienne
- c) étudier le diamètre antéropostérieur du canal cervical
- d) rechercher des ostéophytes.

6) Le matériel nécessaire pour réaliser l'incidence rachis cervical de profil :

- a) statif vertical/Potter
- b) cône localisateur

c) format du film 18*24 ou 24*30 en long

d) diaphragme.

7) La D.F.P dans l'incidence rachis cervical de profil est 1m50 pour :

a)réduire l'agrandissement

b) atténuer le flou cinétique

c) atténuer le flou géométrique

d) toutes ces réponses sont justes.

8) Dans l'incidence rachis cervical de profil, le RD :

a)descendant centré sur la partie moyenne de la face postérieure du cou

b)ascendant de 15° à 20°, vise C4, centré sur le cartilage thyroïde

c)horizontal, vise C4 à mi-hauteur entre l'angle de la mâchoire et l'épaule

d) horizontal centré sur la partie moyenne de la face postérieure du cou.

9) Les critères de réussite de l'incidence profil du rachis cervical :

a) Superposition des angles de la mandibule

b) Superposition des apophyses articulaires droites et gauches

c) dédoublement des murs postérieurs

d) Dégagement impératif de C7.

10) Parmi les variantes de l'incidence rachis cervical de profil :

a) Profil en D.D avec R.D.H

b) Profil en D.V : avec R.D.H

c) Profil en D.L avec R.D.V

d) toutes les réponses sont justes.

11) Le centrage pour l'incidence rachis cervical de face :

a) RD descendant de 15° à 20° centré sur le cartilage thyroïde

b) RD ascendant de 15° à 20° centré sur la fourchette sternale

c) RD descendant de 15° à 20° centré sur la fourchette sternale

d)RD ascendant de 15° à 20° centré sur le cartilage thyroïde.

12)Les critères de réussite de l'incidence du rachis cervical de face sont :

a)Position médiane de la ligne des épineuses

b) Position médiane de la trachée

- c) Position symétrique du maxillaire inférieur
- d) Bonne visibilité des disques intervertébraux de C1C2 à C7D1.

13) Le pourtour de trou de conjugaison est constitué de :

- a) En haut : les apophyses articulaires et leurs interlignes interapophysaires
- b) En avant : l'articulation unco-vertébrale
- c) En bas : le pédicule de la vertèbre sous-jacent
- d) En arrière : le pédicule de la vertèbre sus-jacent.

14) L'identification des trous de conjugaison du rachis cervical en oblique :

- a) O.P.D : on voit les T.G gauches
- b) O.P.G : on voit les T.G droites
- c) O.A.G : on voit les T.G gauches
- d) O.A.D : on voit les T.G droites.

15) Les incidences des épreuves dynamiques de profil du rachis cervical sont au nombre de :

- a) deux
- b) trois
- c) quatre
- d) plus que quatre

16) Radiographie du rachis lombaire, incidence de face :

- a) gros foyer
- b) petit foyer
- c) D.F.P = 1 m
- d) D.F.P = 1.50 m

17) Le centrage dans l'incidence du rachis lombaire de face est

- a) sur la ligne médiane à deux travers de doigt au dessous de la ligne bi-crête
- b) sur la ligne médiane à deux travers de doigt au dessous de la ligne bi-crête
- c) au milieu de la ligne bi-crête
- d) sur la ligne médiane à deux travers de doigt au dessus de la ligne joignant les EIAS.

18) L'incidence indiquée pour l'étude des disques intervertébraux du rachis lombaire de face :

- a) Incidence en antéro-postérieur en décubitus dorsal
- b) Incidence en postéro-antérieur debout ou couché

c) Incidence de débrouillage dite de Desèze

d) aucune incidence.

19) Le centrage pour l'incidence du rachis lombaire de profil :

a) à quatre travers de doigt au dessous de la crête iliaque et à quatre travers de doigts en avant du plan dorsal

b) à quatre travers de doigt au dessus de la crête iliaque et à quatre travers de doigts en avant du plan dorsal

c) à deux travers de doigt au dessous de la crête iliaque et à quatre travers de doigts en avant du plan dorsal

d) à deux travers de doigt au dessus de la crête iliaque et à quatre travers de doigts en avant du plan dorsal.

20) Dans l'incidence oblique du rachis lombaire :

a) l'OPD étale les pédicules, les massifs articulaires et les isthmes du côté gauche

b) l'OPD étale les pédicules, les massifs articulaires et les isthmes du côté droit

c) l'OPG étale les pédicules, les massifs articulaires et les isthmes du côté gauche

d) l'OPG étale les pédicules, les massifs articulaires et les isthmes du côté droit.

21) Le centrage pour l'incidence oblique du rachis lombaire :

a) R.D.H. centré à 5 travers de doigts au dessus de la crête iliaque du côté éloigné du plan d'examen

b) R.D.H. centré à 5 travers de doigts au dessous de la crête iliaque du côté éloigné du plan d'examen

c) R.D.H. centré à 3 travers de doigts au dessus de la crête iliaque du côté éloigné du plan d'examen

d) R.D.H. centré à 3 travers de doigts au dessous de la crête iliaque du côté éloigné du plan d'examen.

22) Dans l'image de l'oblique lombaire les arcs apparaissent comme des petits chiens de la chapelle.

Anatomo-radiologiquement les différentes parties des petits chiens sont :

a) Œil : apophyse transverse

b) Oreille : apophyse articulaire supérieure

c) Museau : pédicule

d) Cou : isthme.

23) Le cône localisateur est indispensable pour les incidences suivantes :

a) charnières lombo-sacrées, Incidence de profil

b) Incidence de profil de la CCO

c) Incidence de débrouillage dite de Desèze

d) Incidence de profil du rachis lombaire.

24) Le centrage pour l'incidence de profil du sacrum :

a) R.D.H. centré de 8 à 10 cm au dessous de la crête iliaque et, de 4 à 8 cm en avant de la face postérieure du sacrum

b) R.D.H. centré de 8 à 10 cm au dessus de la crête iliaque et, de 4 à 8 cm en avant de la face postérieure du sacrum

c) R.D.H. centré de 2 travers de doigts au dessous de la crête iliaque et, de 4 travers de doigts en avant de la face postérieure du sacrum

d) R.D.H. centré de 2 travers de doigts au dessus de la crête iliaque et, de 4 à 8 cm en avant de la face postérieure du sacrum.

25) Le gros foyer est indispensable dans les incidences suivantes :

a) Incidence sacrum de profil

b) Incidence rachis lombaire de profil

c) incidence rachis cervical de profil

d) incidence rachis cervical de face.

26) La D.F.P=1.50 m est utilisée dans les incidences suivantes :

a) incidence rachis cervical de profil

b) incidence oblique du rachis lombaire

c) Incidence de débrouillage dite de Desèze

d) Incidence sacrum de face.

27) Pendant la prise du cliché oblique des cotes :

a) Le coté à radiographier est en contact du plan d'examen,

b) Le coté à radiographier s'écarte du plan d'examen,

c) Le cliché est pris en inspiration forcée et bloqué,

d) Le cliché est pris en expiration forcée.

28) Le centrage de l'incidence de face en antéropostérieur du rachis cervical :

a) RD descendant de 15° à 20°

b) RD ascendant de 15° à 20°

c) RD vise C4

d) RD vise la pomme d'Adam.

29) La position du patient lors de l'incidence de profil du rachis lombaire en station verticale est comme suit :

a) Debout en profil strict

b) Pieds nus bien stables et symétriques

c) Bras croisés sur la poitrine

d) Mains sur les épaules.

30) Les critères de réussite de l'incidence de face du sacrum :

a) Ligne des épineuses bien médiane

b) Superposition pointe de coccyx et de la symphyse pubienne

c) Bonne visualisation des contours de sacrum et des trous sacrés

d) Visualisation de l'ensemble des structures depuis la colonne lombo-sacrée jusqu'au coccyx.

31) Le centrage dans l'incidence sacrum de face :

a) RD descendant

b) RD descendant

c) centré à deux travers de doigts au dessous de la symphyse pubienne sur la ligne médiane

d) centré à deux travers de doigts au dessus de la symphyse pubienne sur la ligne médiane.

32) Les techniques radiologiques du sternum :

a) Incidence de face seulement

b) Incidence de profil seulement

c) Incidences de face et de profil

d) Aucune réponse.

33) Pour la protection du patient et de personnel des rayonnements ionisants, vous devez:

a) Maintenir vous-même les sujets à examiner

b) Revenir derrière un paravent plombé pendant la prise des clichés

c) Vous tenir n'importe où dans la salle pendant la prise des clichés

c) Travailler avec un diaphragme grand ouvert

R: B

34)) Les critères de réussite de l'incidence de la face de l'épaule- Rotation neutre :

a) Articulation gléno-humérale dégagée

b) Superposition de la clavicule et de l'épine de la scapula

c) Tubercule mineur projeté de face au centre de la tête humérale

d) Tubercule majeur projeté de profil vers l'extérieur

R: A B C D

35) l'incidence de Schreck 1 :

- a) Sert à étudier le semi-lunaire (Lunatum)
- b) Met en évidence le scaphoïde de profil
- c) A comme critère de réussite le scaphoïde de face
- d) Rayon Directeur : descendant de 20 à 30°, centré à deux travers de doigts sous l'articulation acromio-claviculaire

R: C

36) La position du malade lors la réalisation de l'incidence de face dorso-palmaire du poignet :

- a) main en pronation
- b) main en supination
- c) doigts relâchés en extension
- d) doigts contractés en flexion

R: A C

37) L'angioscanner thoracique pour embolie pulmonaire :

- a) Ne nécessite pas d'injection de produit de contraste
- b) Le produit utilisé est le gadolinium.
- c) L'acquisition sera réalisée précocement (25 secondes environ après l'injection)
- d) Les clichés fournis au patient seront limités aux fenêtres médiastinales.
- e) L'apnée quand elle est possible n'est pas obligatoire.

R: D

38) L'angioscanner hépatique pour caractérisation d'un nodule du foie :

- a) Est un scanner réalisé pour avoir une cartographie de la vascularisation du foie.
- b) Est un scanner réalisé en deux temps, sans injection et après injection au temps artériel.
- c) Est un scanner réalisé au moins en trois temps.
- d) 60 à 80 secondes après injection correspondent au temps artériel.
- e) L'injecteur automatique n'est pas obligatoire

R AB

39) Concernant les rayons X et la grossesse :

- a) L'exposition aux rayons X est formellement contre-indiquée dans la grossesse débutante.
- b) Les examens à rayons X seront réalisés en 2^o phase du cycle.
- c) l'exposition aux rayons X au 3^o trimestre augmente le risque de malformation fœtale.
- d) Devant une urgence extrême en 3^o trimestre, le recours à un examen à rayons X sera réalisé à défaut d'autre exploration répondant aux questions posées.
- e) Le fait de mettre une blouse plombée sur le pelvis permet une protection efficace et suffisante.

R: A D

40) Concernant la séquence STIR En IRM :

- a) Cette séquence est basée sur la technique d'inversion-récupération
- b) Cette séquence permet l'étude des mouvements de molécules d'eau.
- c) Il s'agit d'une séquence de suppression du signal de l'eau:
- d) Elle est utilisée pour aider au diagnostic de pathologie tumorale du rachis
- e) Elle est souvent associée à la séquence T1 après injection.

R: A